LÝ THUYẾT · MẮT

BÀI 3 Viêm loét giác mạc

Biên soạn lại từ bài giảng 3. Corneal Ulcer - Diagnosis & Treatment.pdf (19 trang) · Giải thích dễ hiểu, kèm 5 hình minh hoạ · Ôn Luyện Nha Khoa

1. GIẢI PHẪU GIÁC MẠC
2. ĐẠI CƯƠNG VÀ CƠ CHẾ BỆNH SINH
3. VIÊM LOÉT GIÁC MẠC DO NẤM
4. VIÊM LOÉT GIÁC MẠC DO VI KHUẨN
5. VIÊM LOÉT GIÁC MẠC DO HSV
6. CHẨN ĐOÁN
7. ĐIỀU TRỊ

Học xong bài này, bạn cần: nêu được đặc điểm dịch tễ, lâm sàng, cận lâm sàng của viêm loét giác mạc; chẩn đoán sơ bộ được tác nhân gây bệnh; nêu được các phương pháp điều trị viêm loét giác mạc nhiễm trùng.

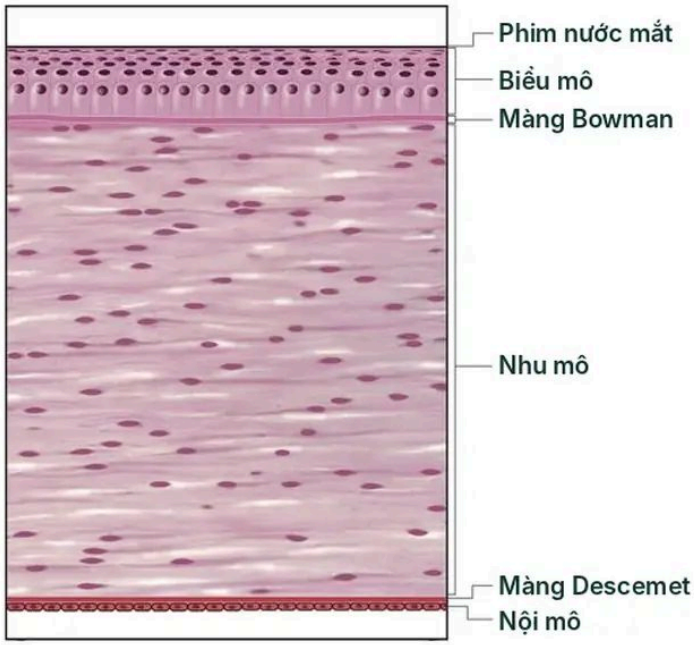
1. GIẢI PHẪU GIÁC MẠC

- Giác mạc là "cửa sổ" trong suốt ở phía trước nhãn cầu. Khi khám bằng **sinh hiển vi đèn khe**, khe sáng cắt qua giác mạc cho ta thấy rõ từng lớp.



Hình 1. Hình cắt lớp của giác mạc khi quan sát qua sinh hiển vi đèn khe.

- Giác mạc có **5 lớp**, từ ngoài vào trong:
  - **Biểu mô**
  - **Màng Bowman**
  - **Nhu mô**
  - **Màng Descemet**
  - **Nội mô**



Hình 2. Năm lớp của giác mạc trên tiêu bản mô học; nhu mô chiếm phần lớn bề dày.

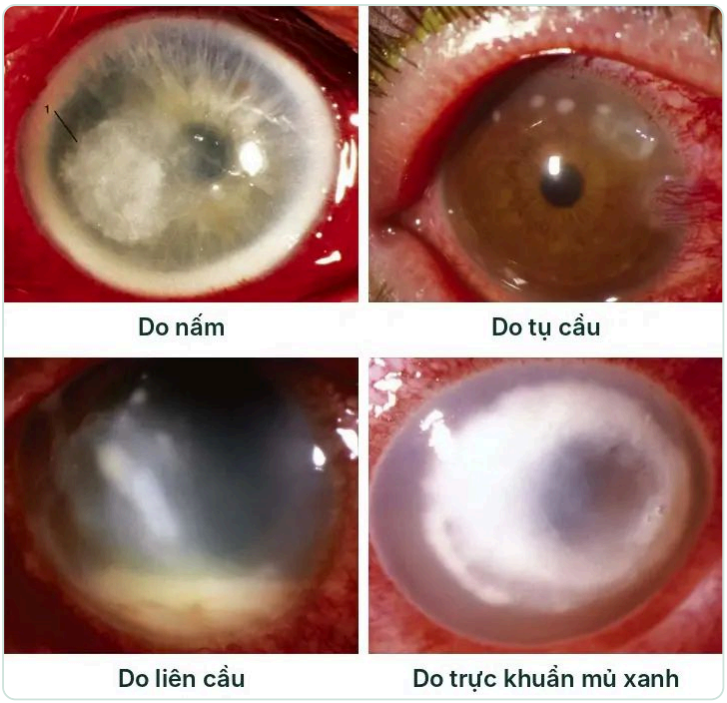
Mẹo nhớ thứ tự 5 lớp: "Bé Bơi Nhanh Dưới Nước" – **B**iểu mô, **B**owman, **N**hu mô, **D**escemet, **N**ội mô.

Vì sao loét giác mạc để lại hậu quả nặng? Lớp biểu mô tái tạo nhanh, xước nông sẽ lành mà không để lại dấu vết. Nhưng khi ổ loét ăn qua **màng Bowman vào nhu mô**, chỗ lành sẽ là **sẹo đục**. Sẹo nằm ở trung tâm thì che mất đường đi của ánh sáng → **giảm thị lực vĩnh viễn**.

2. ĐẠI CƯƠNG VÀ CƠ CHẾ BỆNH SINH

- Viêm loét giác mạc là **nguyên nhân đứng hàng thứ tư gây mù trên thế giới**.
- **Cơ chế bệnh sinh** gồm 3 bước nối tiếp:
  - **Bám dính:** tác nhân bám trên chỗ **biểu mô bị khuyết** (trầy xước, khô mắt, kính tiếp xúc...).
  - **Xâm lấn:** tác nhân **tăng số lượng và dàn trải**, diễn ra mạnh trong **2 ngày đầu**.
  - **Viêm và tổn thương mô:** tác nhân **tiết men hủy mô** → ổ loét lan rộng, sâu dần.

Hiểu nhanh: biểu mô lành lặn là "bức tường" bảo vệ. Hầu hết vi sinh vật **không tự xuyên qua được** biểu mô nguyên vẹn; chúng cần một **vết xước** để bám vào. Vì vậy, chấn thương nhỏ ở mắt và đeo kính tiếp xúc không đúng cách là những yếu tố nguy cơ hàng đầu.



Hình 3. Viêm loét giác mạc do các tác nhân khác nhau: mỗi tác nhân có một "dáng" ổ loét gợi ý.

3. VIÊM LOÉT GIÁC MẠC DO NẤM

Yếu tố nguy cơ

- **Kính tiếp xúc.**
- **Chấn thương, nhất là do thực vật** (cành cây, lá lúa...).
- **Lạm dụng corticoid.**
- Phẫu thuật: **LASIK, ghép giác mạc**.
- **Viêm bề mặt nhãn cầu mạn tính.**

Triệu chứng

- Đỏ; **đau nhức mắt, tăng về đêm**; nhìn mờ; chảy nước mắt; sợ ánh sáng.

Dấu chứng

- **Cương tụ kết mạc.**
- Thâm nhiễm, phù, nhuyễn giác mạc với hình ảnh đặc trưng:
  - **Bờ lông vũ** (bờ ổ loét tua tủa, không gọn).
  - **Sang thương vệ tinh** (các ổ nhỏ rải quanh ổ chính).
  - **Bề mặt gồ**, khô; có thể có **sắc tố**.
- **Mủ tiền phòng.**

> **Liên hệ thực tế:** người làm nông bị **lá lúa, cành cây** quẹt vào mắt, sau vài ngày mắt đỏ, đau nhức về đêm, ổ loét trắng bờ tua tủa → nghĩ ngay **nấm**.

4. VIÊM LOÉT GIÁC MẠC DO VI KHUẨN

Triệu chứng và dấu chứng

- **Triệu chứng:** đỏ, đau, nhìn mờ, chảy nước mắt, sợ ánh sáng.
- **Dấu chứng:**

- **Cương tụ kết mạc.**
- Thâm nhiễm **hình tròn / oval**, phù, nhuyễn giác mạc: **bờ gọn, rõ**; **bề mặt nhẵy, phẳng hoặc lõm**.
- **Mủ tiền phòng.**

- Theo bảng thống kê trong bài giảng: **cầu khuẩn Gram (+) chiếm khoảng 29–53%**, **vi khuẩn Gram (–) khoảng 47–50%** số ca (riêng **Pseudomonas 3–33%**).

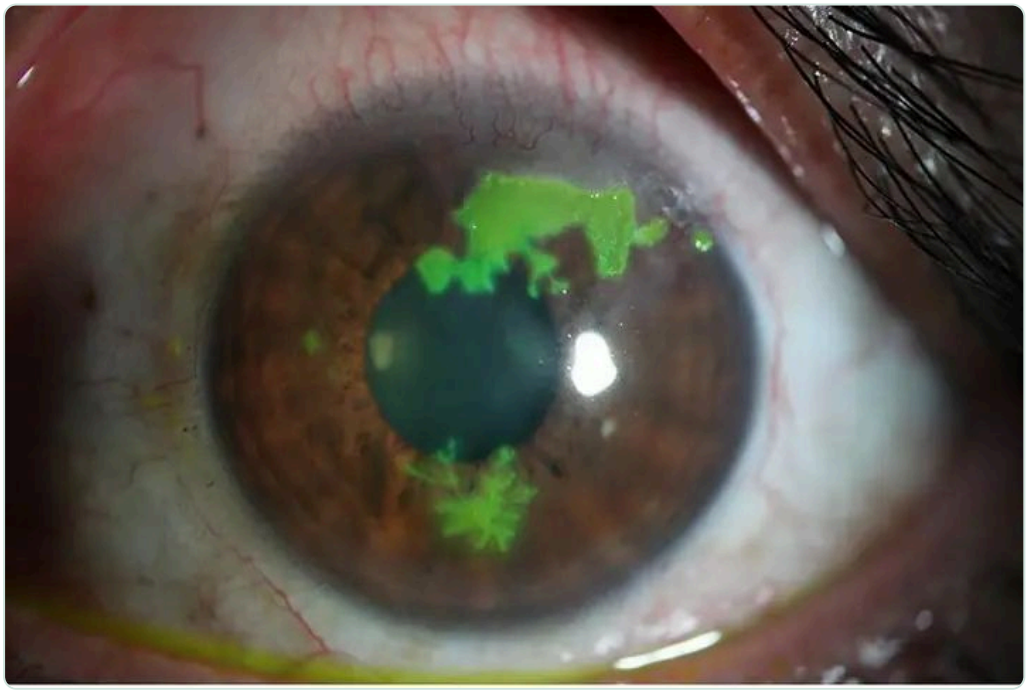
Các vi khuẩn thường gặp

Tác nhân	Đặc điểm
Staphylococci (tụ cầu)	**Gram (+) thường gặp nhất**. Thuận lợi khi **giác mạc đã có bệnh** (khô mắt, viêm giác mạc Herpes, viêm bờ mi, viêm kết giác mạc dị ứng...). **MRSA** gặp **sau phẫu thuật laser**. Tụ cầu coagulase (–) có ở **85% mi mắt người bình thường** → gây **nhiễm trùng cơ hội**
Streptococci (liên cầu)	Thuận lợi sau **chấn thương, viêm túi lệ**, nhiễm trùng bọng. **Diễn tiến nhanh, nhiều mủ, dễ thủng**
Pseudomonas (trực khuẩn mủ xanh)	**Gram (–) thường gặp nhất**. Liên quan **kính tiếp xúc**. **Diễn tiến rất nhanh, nhiều mủ, dễ thủng**

> **Cảnh báo:** người **đeo kính tiếp xúc** bị đau, đỏ một mắt → phải nghĩ tới **Pseudomonas**: ổ loét có thể lan rộng và **thủng giác mạc chỉ trong 1–2 ngày**. Tháo kính, chuyển chuyên khoa ngay.

5. VIÊM LOÉT GIÁC MẠC DO HSV

- **HSV-1:** vùng **hầu họng, mắt**. **HSV-2:** vùng **niệu dục**.
- Diễn tiến 3 giai đoạn:
  - **Nguyên phát:** lần nhiễm đầu, **có hoặc không có triệu chứng**.
  - **Tiềm ẩn:** virus "ngủ" trong **hạch thần kinh**.
  - **Tái hoạt:** khi **miễn dịch suy giảm** (sốt, stress, dùng corticoid...) → bệnh tái phát nhiều lần.



Hình 4. HSV: ổ loét hình cành cây bắt màu xanh khi nhuộm fluorescein.

- **Triệu chứng:** đỏ, nhìn mờ, chảy nước mắt, sợ ánh sáng, **ít đau**.

- **Dấu chứng:**
  - **Cương tụ kết mạc.**
  - Thâm nhiễm, phù, nhuyễn giác mạc **hình cành cây, hình bản đồ**.
  - **Giảm cảm giác giác mạc.**
  - Có thể có **mủ tiền phòng**.

> **Vì sao loét do HSV lại "ít đau"?** Virus sống trong dây thần kinh và làm tổn thương các nhánh thần kinh cảm giác của giác mạc → **giác mạc giảm cảm giác**. Một ổ loét to mà bệnh nhân **ít đau** chính là gợi ý quan trọng của HSV.

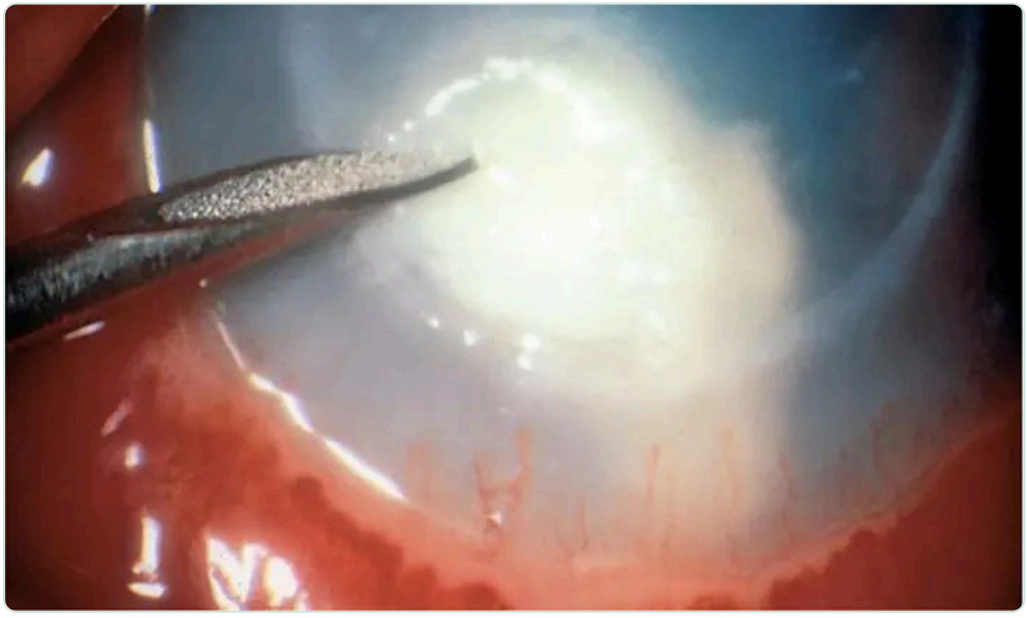
> **Lưu ý: không tự ý nhỏ thuốc có corticoid** cho mắt đỏ chưa rõ nguyên nhân. Corticoid là yếu tố nguy cơ của **loét do nấm** và có thể làm **loét do HSV nặng lên**.

So sánh nhanh 3 tác nhân

Đặc điểm	Nấm	Vi khuẩn	HSV
Hoàn cảnh	Chấn thương thực vật, corticoid	Kính tiếp xúc, chấn thương, giác mạc có bệnh	Tái phát khi giảm miễn dịch
Đau	Đau nhức, **tăng về đêm**	Đau	**Ít đau**
Hình ổ loét	**Bờ lông vũ, ổ vệ tinh**, bề mặt gồ	Tròn/oval, **bờ gọn rõ**, bề mặt nhẵn	**Cành cây, bản đồ**
Dấu riêng	Có thể có sắc tố	Mủ nhiều, dễ thủng	**Giảm cảm giác giác mạc**

6. CHẨN ĐOÁN

- Dựa vào **lâm sàng** và **xét nghiệm: soi tươi, nuôi cấy, nhuộm Gram, PCR**.
- Bệnh phẩm được lấy bằng cách **cạo ổ loét** dưới kính hiển vi.



Hình 5. Cạo ổ loét giác mạc để lấy bệnh phẩm soi tươi, nhuộm và nuôi cấy.

- **Bắt buộc phải làm xét nghiệm vi sinh** khi:
  - Thâm nhiễm giác mạc **rộng, trung tâm, sâu**, có **nhuyễn giác mạc**.

- Nhiễm trùng **kéo dài** hoặc **không đáp ứng với kháng sinh phổ rộng**.
- Có **tiền căn phẫu thuật giác mạc**.
- Sang thương **không điển hình**, gợi ý **nấm, amíp hoặc mycobacterium**.
- Thâm nhiễm **đa ổ**.

> **Hiểu nhanh:** ổ loét nhỏ, ở rìa, điển hình vi khuẩn có thể điều trị kháng sinh phổ rộng trước. Còn ổ loét **nặng, khó, lạ** thì phải biết chính xác tác nhân để chọn đúng thuốc – đó là lý do xét nghiệm trở thành **bắt buộc**.

7. ĐIỀU TRỊ

- **Thuốc:** tại chỗ / toàn thân, **đặc hiệu theo tác nhân** (kháng sinh, kháng nấm, kháng virus).
- **Thủ thuật:**
  - **Dán keo:** bịt chỗ giác mạc mỏng hoặc thủng nhỏ.
  - **Tiêm thuốc vào nhu mô:** đưa thuốc tới sâu trong ổ loét.
  - **Rửa tiền phòng:** lấy bớt mủ trong tiền phòng.
- **Phẫu thuật:**
  - **Ghép màng ối:** giúp bề mặt giác mạc lành lại.
  - **Ghép giác mạc điều trị:** thay phần giác mạc nhiễm trùng không đáp ứng thuốc hoặc đã thủng.
  - **Múc nội nhãn:** khi nhiễm trùng lan khắp nhãn cầu, không thể bảo tồn.

> **Ghi nhớ cả bài:** viêm loét giác mạc là **cấp cứu nhãn khoa**. Nhận ra sớm qua **đau, đỏ, sợ sáng, nhìn mờ, ổ đục trên giác mạc**; đoán tác nhân qua **hoàn cảnh và hình dạng ổ loét**; chuyển chuyên khoa để làm xét nghiệm và điều trị đặc hiệu.

Tài liệu ôn tập biên soạn lại từ bài giảng 3. Corneal Ulcer - Diagnosis & Treatment.pdf. Hình minh hoạ lấy từ bài giảng, nhãn đã dịch sang tiếng Việt. Đối chiếu bài giảng gốc khi cần chi tiết.